

# MOACIR DE LARA

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

Pesca / Arrembo.

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

13/01 P = 6,0

23 IAH = 1,1

M. de uso: 6hr

Bem adaptado

12/03 P = 6,0

2023 IAH = 1,4

m. de uso: 6 horas

Bem adaptado

fuga: 18 l/min.

Auto 7,5 - 6,0

23/06/23 P = 6,0 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 2,1 elv

m. de uso = 6 horas

fuga: 2,5 l/min

Bem adaptado

→ para Press fixa

P: 6 cmH<sub>2</sub>O

05/08 P = 6,0

24 IAH = 0,4 elv

m. de uso: 7hr

fuga = 6 l/min.

lua cláudio

13/05 P = 6,0 cmH<sub>2</sub>O.

25 IAH = 0,6 elv

M. de uso: 6h 40

lua.

Ércio Alvaro Nakano - CRM 84.287  
P. Andréia A. Bisanha - CRM 112.331

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO  
**NAKANO MEDICINA**  
LASER THERAPY

Encaminho Moacir de Lara para adaptação  
De CPAP.

Pressão de calibração: 5,5cm de H2O.

Grata

*Andréia A. Bisanha*  
Otorrinolaringologia  
CRM 112331

**Imunoterapia**

(vacina para alergia)  
teste cutâneo para alergia  
PRICK TEST

**BOTOX**

Microagulhamento  
Biorevitalização  
Intradermoterapia  
Preenchimentos

**Juvéderm**

Fonoaudióloga  
Otorrinolaringologia

Audiometria  
Impedânciometria  
Emissões Otoacústicas  
(teste da orelhinha)  
BERA  
Eletrococleografia  
Vectoeletronistagmografia  
Processamento Auditivo Central  
Vídeo Estroboscopia de Laringe  
Vídeo Endoscopia Nasossinusal  
Vídeo Laringoscopia com foto

CID 10: \_\_\_\_\_

Autorizo a Informação.

CONSULTA DIA:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NAKANO MEDICINA SOC. EMP. LTDA ME - CNPJ 04.518.000/0001-39

\_\_\_\_:\_\_\_\_

**CARAGUATATUBA:**

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 24/25 - 2º andar  
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 12 3883.3849

[www.nakanomedicina.com.br](http://www.nakanomedicina.com.br)  
[contato@nakanomedicina.com.br](mailto:contato@nakanomedicina.com.br)

DR. ALBERTO REMESAR

# LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Moacir de Lara  
EXAME nº: 5137-2 CPAP  
SOLICITADO POR: Dra. Andréia Alessandra Bisanha  
DATA: 05/09/2022  
IDADE: 68 anos

## Comentários:

Exame iniciado às 21h29min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 36 minutos e a latência para o estágio REM, de 109 minutos. O tempo total de sono foi de 437,5 minutos (07h17min), com eficiência de sono (TTS/TTR)\* de 85%. A distribuição do sono registrado mostrou 8,8% de estágio 1, 42,5% de estágio 2, 19,2% de estágio 3 e 29,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 41 minutos em vigília, ocorreram 49 microdespertares (índice: 6,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 4,4/hora, sendo 0 apneia/hora e 4,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 4,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a média de 94% e a mínima de 82%.

(\*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

## CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa shallow (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 5,5 cm de H<sub>2</sub>O. A mentoneira ('queixeira') foi colocada a partir das 22h44min para evitar a saída de ar pela boca.

Os índices de apneia/hipopneia (4,4/hora; índice normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (4,4/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se poucas dessaturações da oxi-hemoglobina e episódios de taqui-bradicardias. As frequências cardíacas foram: mínima: 47; máxima: 57 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada. O paciente demorou a dormir (latência para o sono: 36 min.; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (109 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (85%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (6,7/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (19,2%; normal: 10-12%) e REM (29,5%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (42,5%; normal: 45-55%). A porcentagem do estágio 1 (8,8%; normal: 8-10%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
Diretor Técnico Médico  
CRM-SP 69.730

clínica

**DR. ALBERTO REMESAR**  
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO  
PSQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ  
certificação em Medicina do Sono  
Sociedade Brasileira de Sono  
Mestre em Psiquiatria pela UNESP  
Doutor em Ciências pela UNESP  
CRM-SP: 69.730

Medicina -  
Crianças e Adolescentes  
CRM-SP: 62.858

## LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Moacir de Lara

EXAME nº: 5137

SOLICITADO POR: Dr. Antônio Carlos Zampa

DATA: 28/05/2022

IDADE: 68 anos

### Comentários:

Exame iniciado às 21h00min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 30 minutos e a latência para o estágio REM, de 186 minutos. O tempo total de sono foi de 288,5 minutos (04h48min), com eficiência de sono (TTS/TTR)\* de 54,2%. A distribuição do sono registrado mostrou 21% de estágio 1, 58,6% de estágio 2, 12,3% de estágio 3 e 8,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 213,5 minutos em vigília, ocorreram 145 microdespertares (índice: 30,2/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 72,6/hora, sendo 27 apneia/hora e 45,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 72,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 91% e a mínima de 82%.

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

\* (\*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

### CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (72,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (72,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, episódios de taqui-bradicardia e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 47; máxima: 58 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente dormiu no tempo esperado (latência para o sono: 30 min.; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (186 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 54,2%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 30,2/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21%; normal: 8-10%) e 2 (58,6%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (8,1%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 3 (12,3%; normal: 10-12%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 6 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar López  
Diretor Técnico Médico  
CRM-SP 69.730